



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رضي حسين علي ابراهيم

المحافظة : الجيزة

الحي / المدينة : اوسيم

العنوان : 11ش الايمان بالله -

بشتيل البلد مركز اوسيم

تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

رقم البطاقة : 26602152102141 رقم التليفون : 01206649688

العمر(تاريخ الميلاد) : 15-02-1966 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الاورام

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغه [11127]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :

قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رضى حسين علي ابراهيم National ID: 26602152102141	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
إمارة دبي الشارقة

رضي

حسين علي ابراهيم

اش الايمان بالله-بشتيل البلد

مركز أوسيم - النخيرة

JM1380089

٢٦٦.٢١٥٢١.٢١٤١

١٩-٦٦٤٩٦٨٨

حامو

٢٠٢٢/٠٧ ٢٦٦.٢١٥٢١.٢١٤١



٢٠٢٢/٠٧ ٢٦٦.٢١٥٢١.٢١٤١

ربة منزل



متزوجة مسلمة

عبدالله فاروق مشرف ابراهيم

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/٢٦

١



Radlee Hussein Ali Ibrahim: اسم المريض بالإنجليزية	98727: كود المريض
2026/08/25 01:50:28 PM: تاريخ التقرير	60: السن

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: left axillary lump

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Fatty breast (ACR A).
- Outer central middle third area of distortion and overlaying scattered calcifications, best appreciated in tomo, it measures 2.1x2.5x1.9cm located 4 cm from nipple.
- UOQ middle third lobulated pathological intramammary node confirmed by US , measures 1.4x0.7cm with cortical thickness 0.4mm
- **Ultrasound** 4:00 zone B indistinct area of shadowing correspond to tomo finding
- level I more than 3 discrete pathological nodes, the largest measures 2.7x2cm , near round with lost hilum
- Normal skin and nipple/areolar complex.

Right breast

- Fatty breast (ACR A).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 5): outer central area of distortion & calcifications with pathological axillary nodes, for stereotactic guided & Us guided biopsy

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Dr. Marwa Rainzy, MD, FRCR

Patient Name	رضى حسين على	Case No.	373423
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	26679
Registered Date	09/9/2026 09:11:56 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	06/10/2026 12:25:35 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	06/10/2026 12:25:52 PM	Pathology No.	2860/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass and left axillary lymph node enlargement.

Nature of Specimen:

- 1- Left axillary lymph node, Tru-cut biopsy, collected on 03/09/2026, Cold ischemia time: 20 seconds.
- 2- Left breast mass, Tru-cut biopsy, collected on 03/09/2026, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

Two specimens were received as follow:

Specimen 1: Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Specimen 2: Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

Specimen 1:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- Ductal carcinoma in situ: 5% low grade DCIS (Solid pattern).
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): 10%.

Specimen 2:



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	رضى حسين على	Case No.	373423
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	26679
Registered Date	09/9/2026 09:11:56 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	06/10/2026 12:25:35 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	06/10/2026 12:25:52 PM	Pathology No.	2860/26

- Histologic type: Low grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity) (Done on specimen 1):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane staining in less than 10% of the cells (score 0+).
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

Left breast mass and left axillary lymph node, Tru-cut biopsies:

Specimen 1:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Focal low grade ductal carcinoma in situ (Solid pattern).

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Ultralow (score 0+).
- Ki67%: 20%.

Specimen 2:

- Low grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns).

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى النيل - 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name	رضى حسين على	Case No.	373423
Sex/Age	Female 60 Y	Patient No.	26679
Registered Date	09/9/2026 09:11:56 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	06/10/2026 12:25:35 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	06/10/2026 12:25:52 PM	Pathology No.	2860/26

incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Maha Guimei, MD, PhD.
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى القديسة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building Na. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt